

15 - 06- Risque et Conduites Suicidaires - Pr. MANOUDI

Bonjour, aujourd'hui on va voir les risques et conduites suicidaires. A la fin de ce cours, vous devez être capable d'évaluer le risque suicidaire, déterminer le groupe à haut risque suicidaire, déterminer le facteur de risque suicidaire chez l'adolescent, évaluer l'urgence devant un suicidaire et déterminer la conduite à tenir devant un risque ou une conduite suicidaire. En introduction, quelques messages très importants.

Il ne faut jamais négliger une idée suicidaire. Tenir compte toujours des idées suicidaires, même si c'est dans le cadre d'un chantage. Un suicide réussi, il est toujours possible.

Même si le sujet le fait dans un cadre de chantage, même s'il fait des menaces fréquentes, il peut toujours un jour réussir son suicide. La fréquence des tentatives de suicide chez une même personne ne doit pas être banalisée. Il signale une souffrance psychique.

Ça ne veut pas dire que le sujet le répète plusieurs fois, il le dit plusieurs fois, il essaie plusieurs fois et il ne va pas passer à l'acte. Donc la fréquence, il ne faut pas banaliser la fréquence des tentatives de suicide. Toute tentative de suicide expose à la répétition.

Donc si quelqu'un a fait déjà un antécédent de tentative de suicide, le risque de répéter est toujours possible. La menace de suicide est l'ultime tentative de communication. Des fois, le sujet essaie d'attirer l'attention de l'entourage, de montrer sa souffrance de plusieurs façons, mais quand on ne le comprend pas, la seule façon qu'il lui reste pour communiquer, c'est la menace de se suicider.

Il faut toujours faire attention aux équivalents suicidaires. Les toxicomanies à répétition, l'alcoolisme à répétition, les conduites à risque répétée. Conduire les voitures avec une grande vitesse et prendre ces risques dans sa vie.

Donc en mettant en danger sa vie, ce sont des équivalents suicidaires. Des contre-attitudes négatives du médecin peuvent aggraver la situation, voire précipiter un passage à l'axe suicidaire. Un médecin qui ne fait pas attention, un médecin qui néglige, qui ne fait pas attention aux idées suicidaires, qui n'écoute pas la souffrance de son patient, il peut précipiter le passage à l'axe suicidaire.

Des définitions aussi à retenir. On parle d'un suicide quand on veut dire que la mort, elle est volontaire. Une tentative de suicide, c'est une conduite pour but de se donner la mort sans y aboutir.

Donc c'est une tentative. Une menace de suicide, c'est une conduite faisant craindre la réalisation à court terme d'une tentative de suicide. Le sujet menace, il peut le verbaliser.

Crise suicidaire, c'est une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. Donc ça se

manifeste par des symptômes. Donc on le voit à travers des symptômes, une tension psychique qui montre que le sujet peut passer à l'acte.

Un suicidé, c'est un individu qui s'est déjà donné la mort volontairement. Un suicidant, c'est un individu survivant à une tentative de suicide. Un sujet suicidaire est un individu ayant des idées ou exprimant verbalement ou par son comportement des menaces de suicide.

Malheureusement, on a peu de chiffres au Maroc, mais les chiffres en France sont alarmants. Par exemple, le nombre de décès par suicide, 12 000 par an. 40% de récurrence dans la moitié dans l'année qui suit la tentative de suicide.

2% de décès par suicide dans l'année qui suit la tentative de suicide. 4 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes que chez les hommes et 3 fois plus chez les adolescents. Il y a une surmortalité masculine par le suicide.

Ceci est dû aux moyens utilisés. Les femmes utilisent des moyens des fois qui entraînent moins la mort rapide que les hommes. Devant chaque risque suicidaire, devant chaque menace suicidaire, il faut une évaluation.

On va d'abord commencer par le repérage de la crise suicidaire. Par chercher l'expression d'idées et d'intentions suicidaires et aussi évaluer et chercher le contexte de vulnérabilité. La crise suicidaire peut se manifester au début par une fatigue, une anxiété, des pleurs.

Ce sont des signes qu'on peut trouver dans plusieurs pathologies. Par une irritabilité, par une agressivité, par des troubles de sommeil, par une aboulie, par un sentiment d'échec et d'inutilité, par une perte de l'estime de soi et une dévalorisation, une perte de l'appétit, une boulimie, des ruminations mentales, un retrait, un isolement. Donc il y a des signes qui vont être remarqués par l'entourage et il y a des signes qui vont être verbalisés par le patient.

Ultérieurement, on peut avoir des ruminations morbides, une accalmie des fois soudaine qui peut nous faire suspecter le risque de passage à l'acte et des fois une souffrance psychique intense et un désespoir qui peut être verbalisé ou non par le patient. Sur le plan démographique et social, donc le contexte de vulnérabilité, on va retrouver le sexe masculin, l'adolescent ou bien l'adulte jeune, les divorcés ou veufs, les individus sans profession, les individus qui ont des relations interpersonnelles conflictuelles et les personnes qui ont des problèmes familiaux. Les gens à haut risque par rapport aux troubles et maladies, problèmes de santé, on a les maladies organiques par la souffrance qu'ils entraînent, l'hypochondriaque, donc à force de faire des bilans, de consulter, de ne pas trouver vraiment ce qu'ils cherchent au niveau du diagnostic, la prise excessive de médicaments, les dépressions sévères, les psychoses, les troubles graves de la personnalité, les abus de substances, les délires, donc ça peut être un suicide dans un cadre délirant, le désespoir, l'auto-culpabilité.

Donc pour évaluer aussi les personnes à haut risque, on évalue l'activité suicidaire. Alors la

présence d'idées suicidaires fréquentes est un facteur de risque, aussi s'ils sont intenses et s'ils sont prolongés. Les tentatives de suicide nombreuses, c'est un facteur de risque, surtout s'ils sont prémédités et s'ils se font à un moment où le patient, le sujet, est sûr qu'il ne veut pas être secouru, un désir clair exprimé par le patient, un désir clair de mourir, une communication intérieure, des reproches intérieures, des méthodes létales accessibles, et par rapport aux ressources personnelles et sociales, on trouve qu'un facteur de risque, les faibles réussites, l'insight positif, la pauvreté ou le mauvais contrôle des affects, plus d'irritabilité, plus d'instabilité, d'impulsivité, peu de relations sociales ou familiales, la famille qui est insensible à la souffrance du sujet.

Chez la femme, on peut trouver certaines caractéristiques, notamment la fréquence des tentatives de suicide, l'adulte jeune ou l'adolescente, les femmes veuves ou divorcées, isolées socialement, sans profession, avec beaucoup de conflits familiaux, avec des antécédents dépressifs, antécédents troubles de personnalité, qui présentent des fois des raptus anxieux et qui ont des médicaments à disposition, les produits les plus utilisés chez les femmes, surtout l'HCL ou bien les médicaments. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tentatives de suicide et que de suicide réussit. C'est très important de repérer le risque suicidaire chez l'adolescent.

Il y a des symptômes, des signes qui peuvent nous orienter, notamment le fléchissement des résultats scolaires, la présence de conduites excessives et déviantes, des conduites à risque, par exemple les conduites toxicomaniaques ou bien des conduites automobiles à risque, l'hyperactivité, l'attirance pour la marginalité et les conduites à risque, les troubles des conduites alimentaires, les toxicomanies, la prise de risque inconsidérée, notamment au niveau de la conduite de moto ou d'automobile ou au niveau sexuel, avoir des rapports sexuels non protégés, la violence sur soi ou sur autrui, les fugues, il y a aussi les épisodes dépressifs majeurs, l'existence de troubles psychotiques, de conduites agressives, d'épisodes maniaques, d'abus de substances, l'agressivité, l'impulsivité lors de conflits familiaux ou avec des amis, le sentiment d'humiliation après un échec, l'existence d'événements stressants récents, il y a aussi des facteurs précipitants, notamment les conflits avec la famille ou avec le petit ami, les antécédents de traitements psychiatriques ou d'une tentative de suicide aussi, la perte d'un parent avant l'âge de 13 ans, ça a été aussi décrit, et les antécédents familiaux de suicide. Devant toute idée suicidaire ou bien toute tentative de suicide, il faut évaluer l'urgence en évaluant le niveau de souffrance qui va se manifester par un désarroi et un désespoir extrême, un repli sur soi, de l'isolement, un sentiment de dévalorisation, d'impuissance et de culpabilité, c'est une souffrance morale intense. On évalue aussi l'urgence par l'évaluation du degré d'intentionnalité qui se manifeste par les idées envahissantes, des idées suicidaires envahissantes qui parasitent l'esprit du patient, des ruminations contenant des idées suicidaires, la recherche de l'aide aussi, les attitudes par rapport à des propositions de soins, l'opposition ou bien le refus du soin, le degré de préparation.

Il y a aussi les éléments d'impulsivité, la tension psychique présente, l'instabilité

comportementale, l'agitation motrice, l'état de panique, les antécédents de passage à l'acte, les fugues à répétition ou les actes violents à répétition. Et comme élément précipitant qui nous permet aussi d'évaluer l'urgence, l'existence fréquente de conflits, d'échecs à répétition, de ruptures sentimentales ou amicales, de deuil fréquent aussi. Il y a aussi la capacité de soutien de l'entourage, soit qu'il est absent, soit qu'il n'est pas efficace ou bien peu efficace, la présence de moyens accessibles, soit des médicaments, soit des injections, soit des armes ou bien des objets tranchants.

Le suicide est présent dans toutes les pathologies, presque toutes les pathologies psychiatriques. Il y a les troubles dépressifs, ils peuvent se compliquer, on a vu dans le cours qu'il peut y avoir des dépressions avec des idées suicidaires. Les troubles de l'humeur, que ce soit pendant la phase maniaque ou bien la phase dépressive, le sujet peut passer à l'acte suicidaire.

La schizophrénie aussi, soit dans un cadre délirant, soit lors de la prise de conscience de la maladie. La toxicomanie aussi, l'alcoolisme, donc derrière toute addiction il faut chercher s'il y a une dépression derrière. Les psychopathies, donc par troubles de comportement, impulsivité, instabilité, beaucoup d'agressivité, d'auto-agressivité, d'auto-mutilation.

Les troubles de personnalité, notamment aussi les autres troubles de personnalité, la personnalité bord online, les états limites et les accès psychotiques aigus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire devant des idées suicidaires ou bien devant une tentative de suicide ? Toujours évaluer le risque suicidaire et le risque de récurrence. Évaluer les troubles psychopathologiques sous-jacents pour pouvoir les traiter.

Prendre en compte les interrelations de l'individu avec son entourage. Impliquer la famille dans la prise en charge chez l'adolescent pour favoriser l'alliance thérapeutique. Développer au sein de la famille la capacité de verbaliser les tensions ressenties et les inquiétudes, donc la communication au sein de la famille.

Écouter activement la souffrance psychique du sujet par la famille, par l'entourage et aussi par le médecin. Quand il faut hospitaliser ? Alors quand il y a un risque suicidaire imminent, important, en cas d'épisode dépressif majeur avec des idées suicidaires et ça va de soi, en cas de mélancolie avec des idées suicidaires, en cas de schizophrénie avec des idées suicidaires, en cas d'idée délirante, en cas d'absence de critique du geste et refus de prise en charge en ambulatoire, ça veut dire que le sujet peut récidiver. En cas d'isolement affectif, en cas de mauvaise observance thérapeutique ou automédication, s'il y a des difficultés sociales ou événements de vie douloureux de survenue récente, en cas de présence d'impulsivité ou bien si le patient verbalise clairement ses projets suicidaires.

Le but de l'hospitalisation est d'abord d'éviter le passage à l'acte suicidaire pour le moment, ça permet aussi d'isoler le patient en cas de crise, pour lui permettre une verbalisation de sa

souffrance, permettre une résolution de la crise en milieu protégé, instaurer un lien, une relation de confiance avec le milieu hospitalier et bien sûr pour mettre en route un traitement spécifique si une pathologie psychiatrique est retrouvée et pour mesurer aussi comme l'hospitalisation peut servir comme mesure de sécurité. Si le patient ne nécessite pas l'hospitalisation, en ambulatoire, bien sûr il faut évaluer l'entourage, la qualité de l'entourage, il faut que ce soit un entourage de qualité, affectif, présent et compréhensif, avec une ambiance dédramatisée, donc pour qu'il puisse prendre en charge le patient, une conscience de la crise, de la situation de crise, il faut que l'entourage doit avoir un bon contact, une réponse positive au soutien psychothérapique et l'instauration d'un traitement à posologie efficace bien sûr. Alors en résumé, devant toute crise suicidaire, tentative de suicide, établir une relation de confiance avec le patient, faire une psychothérapie, le risque vital de surdosage par les antidépresseurs ou anxiolytiques, il est toujours présent, faire toujours attention quand on va prescrire un médicament, donner bien sûr les médicaments qui ne sont pas dangereux pour le patient en cas de surdosage, donc il y a des antidépresseurs qui peuvent entraîner la mort en cas de surdosage, d'autres antidépresseurs sont mieux tolérés.

Connaître le délai d'action des antidépresseurs, bien sûr, il faut protéger le patient en attendant l'action des antidépresseurs, faire attention à la levée d'inhibition quand on démarre les antidépresseurs, il y a le risque de levée d'inhibition qui va pousser le patient à passer à l'acte. Ne pas prescrire systématiquement un antidépresseur, évaluer d'abord s'il y a un trouble psychopathologique sous-jacent, prescrire un anxiolytique ou un neuroléptique en fonction de la pathologie sous-jacente pour sédaté le patient, calmer le patient, diminuer son angoisse et permettre de passer la crise suicidaire. Merci.